6.2 환자안전사건 관리			
규 정 번 호	6.2	제 정 일	3주기 규정집 제정
관련 인증기준	6.2 환자안전사건 관리	최근 개정일	2025-10-15
담 당 부 서	QPS실	시 행 일	2025-11-01
검 토 책 임 자	병원 운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	2027-10-15
관 련 근 거	1. 환자안전법 2. 환자안전법 시행규칙		

▣ 목적 (Purpose)

잘못된 시술, 투약오류, 자살, 낙상, 수혈부작용 등의 환자안전 관련 사건을 예방하기 위하여 적절한 보고 체계를 수립 및 학습 시스템을 갖추고, 원인분석 및 개선활동을 효율적으로 수행할 수 있도록 관리한다. 또한 의료기관은 적신호사건 발생 시 환자에게 관련 정보를 제공하고, 주의경보 발령 시 내용에 대해 직원과 공유하여 환자안전문화 형성을 위해 노력한다.

▣ 용어의 정의 (Definition)

- 환자안전사건 : 환자안전에 불필요한 해를 주었거나 환자에게 해를 미칠 수 있는 모든 사고
  투약오류, 수혈부작용, 자해, 도주, 검사 및 시술 중 사고, 감염, 질식, 환경이나 시설 또는 의료기기에 의한 사고, 검사와 관련한 오류, 폭력, 화상, 기타 환자에게 해를 미칠 수 있다고 판단되는 모든 상황 및 사고
- 적신호사건 : 질병의 자연적인 경과와 관계없이 사건의 결과로 예기치 않은 사망이나 신체기능의 영구적인 손실을 가져온 경우
- 위해사건 : 환자의 치료과정이나 업무수행 중 발생된 의도하지 않은 실수나 오류가 환자에게 도달하여 추가적인 치료가 필요해진 경우

* 입원기간의 연장, 중환자실로의 이동 등을 포함한 예상하지 못한 좋지 않은 상황

- 근접오류 : 치료과정이나 업무수행 중 발생된 의도하지 않은 실수나 오류가 시기적절한 중재에 의해 환자에게까지 도달하지 않은 경우

▣ 정책 (Policy)

1. 환자안전사건 관리 절차가 있다.
2. 직원은 환자안전사건의 정의를 알고 발생 시 보고한다.
3. 보고된 환자안전사건을 분류하고 분석한다.
4. 환자안전사건 분석결과에 따라 개선활동을 수행한다.
5. 환자안전사건에 대한 결과를 경영진에게 보고하고 관련 직원과 공유한다.
6. 적신호사건 발생 시 환자와 보호자에게 관련 정보를 제공한다.
7. 환자안전 주의경보 발령 시 관련 직원과 공유한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 환자안전사건 정의 및 분류, 보고

가. 환자안전사건이란 질병이나 치료경과와 무관하게 업무절차 수행과정의 실수나 문제로 인해 환자에게 위해가 발생되거나 발생될 뻔한 사건을 의미하며 본원은 환자안전법 2조 정의 에 따라 보건의료인이 환자에게 보건의료서비스를 제공하는 과정에서 환자안전 위해(사망 · 질환 또는 장해 등 환자의 생명 · 신체 · 정신에 대한 손상 또는 부작용)가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 사고로 정의한다.

나. 환자안전사건 분류

1) 적신호사건 : 질병의 자연적인 경과와 관계없이 사건의 결과로 예기치 않은 사망이나 신체기능의 영구적인 손실을 가져온 경우

2) 위해사건 : 환자의 치료과정이나 업무수행 중 발생된 의도하지 않은 실수나 오류가 환자에게 도달하여 추가적인 치료가 필요해진 경우

* 입원기간의 연장, 중환자실로의 이동 등을 포함한 예상하지 못한 좋지 않은 상황

3) 근접오류 : 치료과정이나 업무수행 중 발생된 의도하지 않은 실수나 오류가 시기적절한 중재에 의해 환자에게까지 도달하지 않은 경우

다. 환자안전 사고 보고(보고자, 보고시기, 보고방법, 보고내용)

1) 보고 내용으로는 환자안전사건의 발생 일시 및 장소, 종류, 발생경위, 환자상태 등을 육하원칙에 의거하여 구두보고 및 환자안전사고별 보고서식을 작성한다.

2) 내부보고

가) 환자안전사고 발생 시 최초 발견자는 응급조치 후 담당의사 또는 당직의사 및 부서장에게 즉시 구두보고한다.

나) 담당의사 또는 당직의사는 상황에 따라 진료적 조치를 취한다.

다) 근접오류의 경우 보고자가 비난의 두려움이 없이 보고할수 있도록 근접오류보고함(익명보고시스템)에 보고할수 있도록하며 최초 발견자는 발생일을 포함하여 5일 이내에 근접오류보고함에 환자안전사고 보고서를 제출하여 보고한다.

라) 위해사건인 경우 최초 발견자는 QPS전담자에게 즉시 구두로 보고하고, 발생일을 포함하여 5일 이내(공·휴일 제외)에 환자안전사고보고서를 작성하여 QPS전담자에게 제출한다.

마) 적신호사건인 경우 최초 발견자는 QPS전담자에게 즉시 구두보고, 발생 24시간이내(공·휴일 제외)에 환자안전사고보고서를 작성하여 QPS전담자에 제출한다.

바) QPS전담자는 구두보고를 받은 즉시 병원장에게 구두보고하고, 제출받은 환자안전사고보고서를 병원장에게 보고한다.

3) 외부보고

※ 환자안전사고가 발생한 경우 질 향상과 환자안전 담당자는 환자안전법 시행규칙에 따라 자율보고로 환자안전보고학습(www.kops.or.kr)에 환자안전사고 보고서를 제출한다.

가) 자율보고

(1) 환자안전법 제 17조(자율보고의 비밀 보장 등)에 의거 보고자의 의사에 반하여 보고자의 정보를 공개할 수 없으며, 자율보고를 한 보건의료기관의 경우에는 그 보건의료기관의장의 의사에 반하여 해당 보건의료기관의 정보를 공개할 수 없다.

나) 의무보고

(1) 보건복지부령으로 정하는 200병상 이상의 병원급 의료기관에서 다음 어느 하나 해당하는 환자안전사고가 발생한 경우 병원장은 보건복지부장관에게 그 사실을 지체 없이 보고 하여야 한다.

(가) 설명하고 동의를 받은 내용과 다른 내용의 수혈로 환자가 사망하거나 심각한 신체적·정신적 손상을 입은 환자안전사고가 발생한 경우

(나) 진료기록과 다른 의약품이 투여되거나 용량 또는 경로가 진료기록과 다르게 투여되어 환자가 사망하거나 심각한 신체적·정신적 손상을 입은 환자안전사고가 발생한 경우

(다) 다른환자나 부위의 수술로 환자안전사고가 발생한 경우(본원 미해당)

(라) 의료기관 내에서 신체적 폭력으로 인해 환자가 사망하거나 심각한 신체적·정신적 손상을 입은 경우

(마) 심각한 신체적·정신적 손상이란 1개월 이상의 의식불명이거나, 장애의 정도가 심한 장애인이 된 경우 이거나, 그 밖의 보건복지부장관이 해당하다 인정하는 경우이다.

2. 환자안전사건 분류 및 분석

가. 정의에 따른 환자안전사건의 분류

오류유형	환자안전사고 단계별 분류	
근접오류	Level 0	사건/사고가 일어날 뻔 했으나 우연한 또는 시의 적절한 중재를 통해서 발생이 안됨
	Level 1	사건/사고가 발생했으나 환자에게 해가 없음
위해사건	Level 2	사건/사고의 발생으로 인한 치료 또는 중재를 필요로 함
	Level 3	입원기간이 연장되거나 퇴원 시 장애를 일으키는 사건/사고
적신호사건	Level 4	주요 기능의 영구적 손실을 가져오거나 사망을 초래함

나. 분류된 환자안전사건의 분석방법

적신호사건(Level 4-또는 가장 높은 레벨)의 근본원인분석(RCA, Root Cause Analysis) 및 개선 활동 수행

1) 적신호 사건 유형 : '자살, 혈액형 불일치, 수혈, 질환의 자연적인 경과와 관계없이 입은 영구적인 손상이나 사망' 등이다.

2) QPS팀 구성 : 관련부서/진료과와 함께 의사결정권한을 가진 자를 포함하여 개선에 결정적으로 중요한 사람들로 구성한다.

3) 근본원인분석 : 적신호사건 발생 후 45일 이내에 근본원인분석(RCA)을 실시한다.
   - 예기치 못한 사건을 발생시키는 내재적인 기본요인과 원인이 되는 요인을 규명

4) 근본원인분석 및 개선활동 수행단계에는 다음의 내용을 포함한다.

가) 1단계 : 문제 확인 - 문제발생 장소 및 시점 규명

나) 2단계 : RCA팀 구성

다) 3단계 : 원인분석-프로세스 분석 및 단계 확인

라) 4단계 : 기여요인분석-인적자원 및 시스템/프로세스 분석

마) 5단계 : 개선활동 계획 및 수행-책임자, 활동기간, 활동내용

바) 6단계 : 결과평가-지표 및 효과측정방법 선정

다. 적신호 사건 외(위해사건(Level 2-3) / 근접오류(Level 0-1))-또는 가장 높은 레벨 이외에대한 원인분석 및 개선 활동 수행

1) FMEA오류(고장)유형 및 영향분석 보고서에는 다음의 내용을 포함한다.

가) 1단계: 고위험 프로세스 선정 및 팀구성

나) 2단계: 프로세스 검토
다) 3단계: 잠재적 고장유형을 브레인스토밍하고, 고장유형의 효과를 정리
라) 4단계: 고장유형의 우선순위 설정
마) 5단계: 고장유형의근본원인 규명
바) 6단계: 프로세스의 재설계(Redesign)
사) 7단계: 새로운 프로세스의 분석과 검증
아) 8단계: 새로운 프로세스의적용과 모니터링

3. 개선활동 수행

가. 분석 결과에 따라 우선순위를 정하여 개선활동을 수행한다.

4. 환자안전사건 결과에 대한 경영진 보고 및 관련직원 공유

가. 환자안전사건 결과에 따라 RCA 또는 FMEA 방법으로 분석하고 개선활동을 계획 및 시행하여 QPS위원회 및 병원장에게 보고한다.

나. 적신호사건, 위해사건, 근접오류 등을 분석하여 개선활동을 수행한 결과는 원내게시판, 회람 등을 통해 관련 직원과 공유한다.

5. 적신호 사건(또는 가장 높은 레벨)발생 시 환자 및 보호자에게 관련 정보 제공 절차

가. 진료과정에서 발생한 내용, 치료계획 등으로 적신호 사건 발생 시 주치의는 환자 및 보호자에게 설명한다.

나. 적신호사건 발생에 대한 환자 및 보호자에게 진료과정에서 발생한 내용을 자세히 설명한다.

다. 설명 시에는 발생한 내용 및 조치사항 등에 대해 정확한 사실 정보만을 제공하고 앞으로의 치료계획을 설명한다.

6. 환자안전 주의 경보 발령 시 정보 제공

가. 국가에서 발령하는 환자안전 주의경보

「환자안전법」제 16조에 의거하여 환자안전 주의경보가 발령되면 환자안전전담자는 주 의경보를 인지하고 본원이 제공하는 의료서비스와 관련된 주의경보를 회람을 통해 관련직원과 공유한다.

나. 의료기관 차원에서 선정한 환자안전 주의경보

1) 원내에서 발생한 환자안전사건 중 새로운 유형의 환자안전사건 또는 재발 시 환자안전에 중대한 위해가 발생할 우려가 있는 환자안전사건과 RCA 분석을 시행한 내용을 고려하여 발령할 수 있으며, 해당 내용과 관련된 환자안전 주의경보가 있는 경우 재공지도 가능하다.
2) QPS위원회에서 의료기관 차원의 환자안전 주의 경보 발령에 대해 결정하고 게시판을 통해 직원과 공유한다.

▣ 부록 (Appendix)

1. 환자안전사고 보고서(내부)
2. 환자안전사고 보고서(외부)
3. 환자안전 보고체계(내부)
4. 환자안전 보고체계(외부)

▣ 규정 개정일 [누적]

2025년 10월 15일 개정하고 2025년 11월 1일 시행한다.

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일					

부록1. 환자안전사고 보고서(내부)

환자안전사건 보고서

결재	부서장	QPS전담자	병원장

발 생 일 시	____년 ____월 ____일 ____시			보 고 일	____년 ____월 ____일 ____시		
등록번호/이름	____ / ____			성별/나이	____ / ____	해당병동	____
보 고 부 서	☐ 병동 ☐ 외래 ☐ 검사/특수부서 ☐ 약제부 ☐ 기타 ____			보고자(작성자)	____		
관련 직원(중복선택가능)	☐ 의사 ☐ 약사 ☐ 간호사 ☐ 의료기사 ☐ 기타 ____						
발 생 장 소	☐ 병실 ☐ 화장실 ☐ 복도 ☐ 계단 ☐재활치료실 ☐ 기타(____)						
오류 구분	☐ 낙상 ☐ 투약 ☐ 기타						
오류등급 분류 (오류 발생 후 환자의 상태에 'V' 표시)	☐	0	사건/사고가 일어날 뻔 했으나 우연한 또는 시의 적절한 중재를 통해 발생이 안됨			근접오류	
	☐	1	사건/사고가 발생했으나 환자에게 해가 없음				
	☐	2	사건/사고의 발생으로인한 치료 또는 중재를 필요로함			위해사건	
	☐	3	입원 기간이 연장되거나 퇴원 시 장애를 일으키는 사건/사고				
	☐	4	주요기능의 영구적 손실을 가져오거나 사망을 초해함			적신호사건	

오류 유형(중복 선택 가능)		
낙상	의식상태	☐명료(alert) ☐졸음(drowsy) ☐혼미(stupor) ☐반혼수(semicoma) ☐혼수(coma)
	활동상태	☐독립적 ☐부분적인 도움(보조기구 사용) ☐항상 도움 필요 ☐침상 안정 상태
	환자위험 요인 (중복 선택 가능)	☐흥분 ☐어지러움 ☐전신쇠약 ☐마비 ☐시력장애 ☐체위성저혈압 ☐평형장애 ☐보행장애 ☐수면장애 ☐낙상 과거력 (1년 이내) ☐기타
	낙상유발 위험약물	낙상 발생 24시간 이내 투여된 ☐항우울제 ☐항불안제 ☐항정신치료제 ☐ 최면진정제 ☐이뇨제 ☐기타
	낙상유형	☐ 침대 사용 시 ☐ 의료 장비 사용 시 ☐ 기립/보행 시 ☐ 유모차 사용 시 ☐ 의자 사용 시 ☐ 기타 ____
	낙상 위험요인	☐ 침대바퀴 고정 안함 ☐ 보조 난간 내려짐 ☐ 바닥의 물기 ☐ 발에 맞지 않는 신발 ☐ 주변물건에 걸려 넘어짐 ☐ 기타(____)
투약 오류	투약전 발견	☐ 의사처방 오류 ☐ 약사조제/불출오류 ☐ 기타(____)
	투약 후 발견	☐ 다른 환자 ☐ 다른 약품 ☐ 다른 시간 ☐ 다른 경로 ☐ 다른 용량 ☐ 약물 부작용 ☐ 투약하지 않아야 할 상황에서의 투약 ☐ 기타(____)
기타 오류		☐ 검사관련: ☐ 과정 오류 ☐ 결과 오류 ☐ 검사 지연 ☐ 자살 및 자해(시도) ☐ 진료 재료 오염/불량 ☐ 화상 ☐ 시술 관련 ☐ 의료장비 및 기구관련 ☐ 기타(____)

활력징후 (낙상의 경우 낙상점수포함)	
신체 손상정도	
사고발생 후 치료내용	
사건경위	언제: 어디서: 무엇을: 어떻게: 왜: 했나:
문제원인 및 개선방안	

부록2. 환자안전 사고보고서(외부)

■ 환자안전법 시행규칙 [별지 제5호서식]

환자안전사고 보고서

(보건의료인 · 보건의료기관장 · 전담인력 제출용)

※ 해당되는 [ ]에 √표시하며, 작성란이 부족한 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 음영란은 「환자안전법」 제14조제2항에 따른 의무보고 시 반드시 작성해야 합니다.

※「환자안전법」 개정에 따라 환자안전사고 보고 서식이 2021년 1월 30일 이후 일부 변경되었습니다.

보고서 정보	자료공개여부	[ ]공개 [ ]비공개
	의무보고 대상	[ ]예 [ ]아니오
사고정보	사고 발생일시	년 월 일 시
	보건의료기관 소재지	[ ]서울 [ ]부산 [ ]대구 [ ]인천 [ ]광주 [ ]대전 [ ]울산 [ ]세종 [ ]경기 [ ]강원 [ ]충북 [ ]충남 [ ]전북 [ ]전남 [ ]경북 [ ]경남 [ ]제주
	보건의료기관 구분	[ ]상급종합병원 [ ]종합병원 [ ]병원 [ ]치과병원 [ ]한방병원 [ ]요양병원 [ ]정신병원 [ ]의원 [ ]치과의원 [ ]한의원 [ ]조산원 [ ]약국 [ ]보건소 [ ]보건지소 [ ]그 밖의 기관( )
	병상 수	[ ]없음 [ ]200병상 미만 [ ]200병상 이상 500병상 미만 [ ]500병상 이상
	사고 발생장소	[ ]외래진료실 [ ]입원실 [ ]중환자실 [ ]응급실 [ ]검사실 [ ]주사실 [ ]처치/시술실 [ ]수술실 [ ]회복실 [ ]원무과 [ ]약제실 [ ]재활 · 물리치료실 [ ]인공신장실 [ ]화장실 [ ]샤워실 [ ]배선실 [ ]복도 [ ]식당 [ ]휴게공간 [ ]주차장 [ ]약국 [ ]그 밖의 장소( )
	관련 직원 (중복선택 가능합니다)	[ ]의사 ([ ]인턴 [ ]일반의 [ ]전공의 [ ]전문의) [ ]치과의사 ([ ]인턴 [ ]일반의 [ ]전공의 [ ]전문의) [ ]한의사 ([ ]인턴 [ ]일반의 [ ]전공의 [ ]전문의) [ ]약사 [ ]한약사 [ ]간호사 [ ]간호조무사 [ ]의료기사([ ]방사선사 [ ]임상병리사 [ ]물리치료사 [ ]작업치료사 [ ]치과기공사 [ ]치과위생사) [ ]보건의료정보관리사 [ ] 간병인 · 요양보호사 [ ]그 밖의 직원( ) [ ]관련 직원 없음
	관련 직원 경력 (관련 직원이 다수일 경우 중복선택 가능합니다)	[ ]1년 미만 [ ]1년 이상 3년 미만 [ ]3년 이상 5년 미만 [ ]5년 이상~10년 미만 [ ]10년 이상
	사고 발생단계	[ ]외래진료([ ]내원 전 [ ]진료대기 중 [ ]진료 중 [ ]진료 후 [ ]진료의뢰) [ ]입원진료([ ]입원전 [ ]치료 및 수술전 [ ]치료 및 수술중 [ ]수술 직후 또는 중환자실 관리 [ ]일반병동치료 [ ]전과 및 전동 [ ]이송 [ ]퇴원 [ ]퇴원 후) [ ]약국 [ ]가정간호 [ ]그 밖의 단계( )
	사고 발견일시	년 월 일 시
	사고 발견단계	[ ]외래진료([ ]내원 전 [ ]진료대기 중 [ ]진료 중 [ ]진료 후 [ ]진료의뢰) [ ]입원진료([ ]입원전 [ ]치료 및 수술전 [ ]치료 및 수술중 [ ]수술 직후 또는 중환자실 관리 [ ]일반병동치료 [ ]전과 및 전동 [ ]이송 [ ]퇴원 [ ]퇴원 후) [ ]약국 [ ]가정간호 [ ]그 밖의 단계( )
	발견과정	[ ]관련직원이 문제를 인지 [ ]환자상태 변화

		[ ]의료기기·경보장치 등의 알람 [ ]내부 점검체계에 의한 발견 [ ]사전평가(욕창, 자살사정도구 등)를 통한 위험요인 파악
	발견자	[ ]의사 ([ ]인턴 [ ]일반의 [ ]전공의 [ ]전문의) [ ]치과의사 ([ ]인턴 [ ]일반의 [ ]전공의 [ ]전문의) [ ]한의사 ([ ]인턴 [ ]일반의 [ ]전공의 [ ]전문의) [ ]약사 [ ]한약사 [ ]간호사 [ ]간호조무사 [ ]의료기사([ ]방사선사 [ ]임상병리사 [ ]물리치료사 [ ]작업치료사 [ ]치과기공사 [ ]치과위생사) [ ]보건의료정보관리사 [ ]간병인 · 요양보호사 [ ]응급의료종사자 [ ]자원봉사자 [ ]다른 환자 [ ]친인척 [ ]보호자 [ ]친구 · 방문자 [ ]그 밖의 경우( )
	사고 종류 (중복선택 가능합니다)	[ ]행위 측면 [ ]검사 [ ]마취·진정 [ ]분만 [ ]수술 [ ]수혈 [ ]약물 [ ]처치 · 시술 [ ]결과 측면 [ ]감염 [ ]낙상 [ ]화상 [ ]관리 측면 [ ]상해 [ ]식사 · 영양 [ ]의료장비 · 기구 [ ]진료재료(소모품) [ ]탈원 · 실종 · 유괴 [ ]행정 [ ]환자의 자살 · 자해 [ ]그 밖의 종류( )
	위해정도	[ ]근접오류(Near miss) [ ]위해없음(None) [ ]경증(Mild) [ ]중등증(Moderate) [ ]중증(Severe) [ ]사망(Death)
	사고 발생 후 환자에 대한 조치사항 (중복선택 가능합니다)	[ ]조치 [ ]기관 내 전과나 전동, 전원, 외래환자의 경우 응급실 방문/입원 등 [ ]보존적 치료 [ ]추가 검사 [ ]투약치료 [ ]처방변경 [ ]전문심장소생술(ACLS) [ ]수혈 [ ]수술, 시술 [ ]산소투여, 인공호흡기 치료 등 [ ]심리치료 [ ]교육 [ ]재불출 [ ]단순처치 [ ]재조제 [ ]협진 [ ]기록 [ ]그 밖의 조치( ) ※ 사고발생부터 조치까지의 기간 [ ]30분 이내 [ ]30분 이상 ~ 1시간 이내 [ ]1시간 이상 ~ 6시간 이내 [ ]6시간 이상 ~ 12시간 이내 [ ]12시간 이상 ~ 24시간 이내 [ ]24시간 이상 [ ]알 수 없음 [ ]미조치
	내부보고 여부	[ ]보고 수행 [ ]보고 미수행
	환자설명 여부	[ ]설명 수행 [ ]설명 미수행 [ ]알 수 없음
환자정보	생년월일	년 월 일
	연령대	[ ]1개월 미만 [ ]30~39세 [ ]1개월 이상 12개월 미만 [ ]40~49세 [ ]1~4세 [ ]50~59세 [ ]5~9세 [ ]60~69세 [ ]10~19세 [ ]70~79세 [ ]20~29세 [ ]80세 이상

	성별	[ ]남자 [ ]여자				
	환자 진료과목					
	사고발생 진료과목 (중복선택 가능합니다)					
	내원 시 진단명 [한국표준질병 사인분류(KCD)에 따라 적습니다] 또는 증상					
	사고 전 환자상태 [한국표준질병 사인분류(KCD)에 따라 적습니다]					
보건의료기관 정보	요양기관기호		요양기관명		법인명	
	종 별		대표자명		허가 병상 수	
	주 소					
보고자 정보	보고자 구분	[ ]보건의료인 [ ]보건의료기관의 장 [ ]전담인력				
	연 락 처			전자우편		

사고내용

※ 사고발생 당시의 상황, 내용 및 조치사항 등을 육하원칙에 따라 구체적으로 적습니다.

사고원인

※ 사고발생이전 단계에서 선행 기여요인이 무엇인지를 포함하여 사고원인을 구체적으로 적습니다.

기여요인	[ ]직원요인	[ ]환자요인	[ ]업무·환경요인
	[ ]기관 · 서비스요인	[ ]외부요인	[ ]그 밖의 요인( )

사고예방 및 재발방지를 위한 개선방안

국가 수준	
보건의료기관	

수준	

「환자안전법」제14조제1항 또는 제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항에 따라 위와 같이 환자안전사고를 보고합니다.

년 월 일

보고자 (서명 또는 인)

보건복지부장관 귀하

210mm×297mm[백상지 (80g/m²)]

부록3. 환자안전 보고체계(내부)

환자안전사고 내부 보고체계

1. 사고 발견 및 초기 대응

환자안전 사고 발견 시 환자 상태를 확인하고 즉각적인 **응급조치**를 시행합니다.

2. 즉시 구두 보고

- **일반 사고:** 담당/당직 의사 및 단위 부서장에게 즉시 구두 보고
- **위해/적신호 사건:** **QPS 전담자**에게 즉시 구두 보고 ➡ 병원장 최종 구두 보고

3. 서류 작성 및 제출

해당 직원이 『환자안전사고 보고서』를 작성한 후 **QPS 전담자**에게 제출합니다.

사고 유형별 서류 보고 기한 (필독)

근접오류	위해사건	적신호사건
발생일 포함 **5일 이내**	발생일 포함 **5일 이내** (공휴일 제외)	발생 **24시간 이내** 즉시 (공휴일 제외)

부록4. 환자안전 보고체계(외부)

🌐 환자안전사고 외부 보고체계

환자안전사고를 발생시켰거나 사실을 알게 된 **보건의료인, 보건의료기관의 장, 전담인력, 환자 또는 보호자**가 직접 보고할 수 있습니다.

🔒 **「환자안전법 제 17조」에 의거, 자율보고자의 의사에 반하여 보고자의 정보는 철저히 비밀 보장됩니다.**

📌 보고 방법 (환자안전보고학습시스템)

💻 홈페이지
www.kops.or.kr

📧 이메일
patientsafety@koiha.or.kr

📠 팩스
02-6499-1666

📮 우편 접수
서울 영등포구 국회대로76길 10
K.B.C빌딩 8층 의료기관평가인증원
환자안전담당자 앞

📝 보고 절차

1. 홈페이지 메인화면의 **[보고하기] ➡ [보고가이드]** 클릭
2. **'환자안전보고서 서식'** 다운로드 및 내용 작성
3. 작성된 서식을 **이메일, 팩스, 우편** 중 편한 방법으로 접수